

TREINAMENTO DE PROTOCOLOS GERENCIADOS E PASSAGEM DE CATETER CENTRAL

PCL.AS.CEGISS.AH.001.003 - PROTOCOLO DE SEPSE

PCL.AS.CEGISS.AH.003.004 - PROTOCOLO DE DOR TORACICA E IAM

PCL.AS.CEGISS.AH.005.002 - PROTOCOLO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

PCL.AS.CEGISS.RUE.005.002 - PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA

Passagem de Cateter Central

Elaboração: Gestão da Qualidade Performa Saúde

PROTOCOLOS TEMPO

Protocolos Institucionais que Impactam Diretamente o Desfecho do Paciente

01

Protocolo de Seps

Tempo é sobrevivência. Cada minuto é crucial para o tratamento e recuperação do paciente.

02

Protocolo de Dor Torácica e IAM

Tempo é músculo. Intervenção rápida minimiza o dano ao coração e preserva a função cardíaca.

03

Protocolo de AVC com Trombólise

Tempo é neurônio. Ação rápida salva células cerebrais e reduz sequelas neurológicas.

04

Protocolo de Atendimento ao Trauma

Tempo é vida. Resposta imediata e coordenada define a sobrevivência e a qualidade de vida pós-lesão.

TREINAMENTO PROTOCOLO DE SEPSE

Guia prático para reconhecimento precoce e manejo efetivo da sepse na urgência

Quando abrir o protocolo (caso suspeito)

	Suspeita Clínica Infecção com disfunção orgânica, mesmo sem confirmação laboratorial.
	Critérios de SIRS Pacientes com ≥ 2 critérios de SIRS e suspeita infecciosa.
	Populações Específicas Idosos, imunossuprimidos ou frágeis: ausência de critérios clássicos não exclui sepse.
	Sinais de Alerta Hipotensão, alteração da consciência, oligúria, hipoxemia e lactato elevado.

Meta assistencial

 Reduzir Mortalidade Diminuir óbitos por sepse e suas complicações.	 Prevenir Choque Séptico Evitar progressão para choque séptico e falência múltipla de órgãos.	 Tratamento Rápido Garantir tratamento completo dentro da "Golden Hour".
---	--	---

Bundle da Primeira Hora

	
Abertura imediata do protocolo	Coleta de lactato (até 1h)
	
Coleta de culturas (antes do antibiótico)	Antibiótico EV (até 1h)
	
Reposição volêmica: 30 ml/kg (em até 60 min)	Início de noradrenalina (se hipotensão persistente)

Medicações Essenciais

- Antibiótico EV de amplo espectro
- Cristalóide (preferencialmente Ringer lactato)
- Noradrenalina (em casos de choque)



Ponto crítico de melhoria

Atraso no início do antibiótico devido à espera por exames complementares.

♥ PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA / SCA

Quando abrir o protocolo (caso suspeito)

- Sempre que houver possibilidade de origem cardíaca.
- Sintomas comuns: dor torácica (típica ou atípica com fatores de risco), dispneia, náuseas, vômitos, sudorese fria, dor epigástrica, síncope.
- **Atenção: Idosos, diabéticos e mulheres exigem avaliação mesmo sem dor típica.**

Meta assistencial

- Diagnóstico precoce de Síndrome Coronariana Aguda (SCA).
- Reperusão no menor tempo possível.
- Redução da mortalidade e disfunção ventricular.



Abertura imediata do protocolo



Realização de ECG em até 10 minutos



Definição diagnóstica imediatamente após o ECG



Início da reperusão no menor tempo viável

Medicações essenciais

- Ácido acetilsalicílico em dose de ataque
- Heparina quando indicada
- Nitroglicerina quando indicada
- Trombolítico quando aplicável



Ponto crítico de melhoria

ECG tardio e subvalorização de dor torácica atípica.



Fluxo do Protocolo de SCA (Dor torácica)

1 Identificação Inicial

Identificar sinais ou sintomas sugestivos de dor torácica, típicos ou atípicos.
Considerar fatores de risco cardiovascular e apresentação clínica.

2 Abertura do Protocolo

Abrir **obrigatoriamente** o Protocolo de Dor Torácica. (FICHA), garantir preenchimento completo.
Solicitar os exames iniciais previstos no protocolo institucional.
Garantir monitorização clínica adequada.

3 Passagem do Caso

Obrigatoriamente, Realizar passagem **formal e objetiva** do caso ao médico da emergência, incluindo:

- Queixa principal
- Tempo de início dos sintomas
- Achados clínicos
- Exames já realizados

4 Avaliação pela Emergência

Reavaliar clinicamente o paciente.
Analisar exames iniciais e evolução clínica.
Assumir integralmente a condução do caso registrando em prontuário.

5 Tomada de Decisão

Definir, com base clínica e protocolar:

Encerramento do protocolo, quando descartada hipótese de SCA, ou **Manutenção do protocolo**, com seguimento conforme diretrizes institucionais.

6 Regras de Encerramento e Acionamento

Em nenhuma hipótese poderá ser negado o seguimento do Protocolo na Emergência, salvo quando o médico da emergência **descartar a hipótese de Síndrome Coronariana Aguda (SCA)**, com **registro em prontuário e encerramento da ficha gerenciada**.

Em caso de dúvida, a **Coordenação da Emergência (Dra. Mariana)** e a **Coordenação da Porta e Enfermaria** devem ser acionadas imediatamente.

PROTOCOLO DE AVC E TROMBÓLISE

Quando abrir o protocolo (caso suspeito)

Acionar protocolo diante de déficit neurológico focal de início súbito, mesmo com melhora dos sintomas.

- Sintomas como assimetria facial, fraqueza/perda sensitiva unilateral.
- Alteração da fala, perda visual súbita, ataxia, vertigem ou rebaixamento da consciência.

Registro imediato do "last seen well" é obrigatório.

Ponto crítico de melhoria

Perda de tempo terapêutico por falha de fluxo ou ausência de registro do início dos sintomas.

Meta assistencial

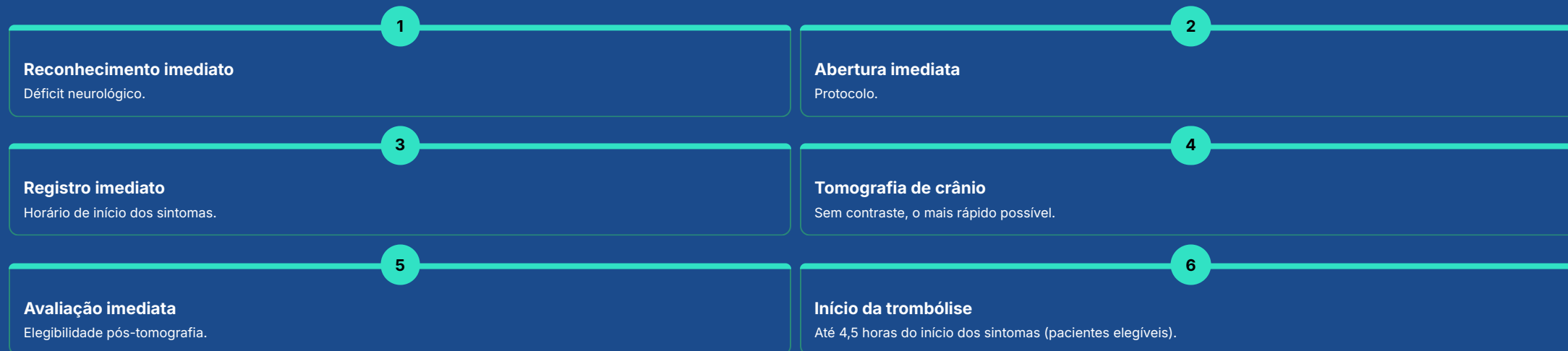
- Reduzir mortalidade e sequelas neurológicas incapacitantes.
- Garantir decisão terapêutica e trombólise dentro da janela em pacientes elegíveis.

Medicações essenciais

- **Alteplase endovenosa:** 0,9 mg/kg (10% bolus, restante em 60 min).
- Antiagregante plaquetário (se trombólise não indicada).
- Controle rigoroso da pressão arterial e monitorização neurológica.

Quando NÃO trombolisar

- AVC hemorrágico (na tomografia).
- Janela terapêutica ultrapassada.
- Hipertensão não controlada.
- Sangramento ativo ou alto risco hemorrágico.





PROTOCOLO DE TRAUMA

Quando abrir o protocolo (caso suspeito)

Abrir com base no mecanismo de trauma, independentemente da queixa inicial. Considerar:

- Mecanismos de alto impacto (quedas, atropelamentos, colisões).
- Lesões por agressão ou ferimentos penetrantes.
- **Importante: Paciente consciente e estável não exclui trauma grave.**

Meta assistencial

- Tratar ameaças imediatas à vida.
- Evitar morte precoce.
- Estabilizar o paciente para investigação definitiva.



Tempos críticos

- Avaliação primária (ABCDE) imediata.
- Controle urgente de via aérea e hemorragia.
- Oxigenação e acesso venoso sem atraso.
- Avaliação secundária APENAS após estabilização.



Medicações essenciais

- Cristaloídes aquecidos.
- Ácido tranexâmico (em até 3h para sangramentos).
- Analgesia e sedação conforme a clínica.



Ponto crítico de melhoria

Evitar exames antes da estabilização inicial.



Cateter Central

AS PRINCIPAIS INDICAÇÕES INCLUEM:



Acesso Periférico Inadequado

Dificuldade de acesso venoso periférico ou infusão complexa.



Protocolo Adventista

Administração de todas as drogas vasoativas (conforme protocolo).



Terapias Extracorpóreas

Acesso venoso calibroso para plasmaférese, ECMO, hemodiálise e hemofiltração.



Infusão Incompatível

Medicações que causam flebite (vasopressores, soluções hiperosmolares, químicos).



Monitoramento Hemodinâmico

Avaliação contínua de parâmetros como pressão venosa central.



Inserção de Dispositivos

Filtro de veia cava, stent, angioplastia venosa, trombólise e cateter arterial pulmonar.

Locais de Escolha



Veias Jugulares Internas (VJD/VJE)

- Opções primárias para acesso.
- **VJD:** Primeira escolha geral.
- **VJE:** Preferível sem necessidade de Shilley ou risco de insuficiência renal.



Veia Subclávia

- Utilize apenas se jugulares inviáveis.
- Requer **justificativa e discussão** com supervisor.
- Opção preferencial entre as vias alternativas.



Veia Femoral

- Considerada a **última opção**.
- Apenas se outras vias esgotadas.
- Exige **rígida justificativa e aprovação** do supervisor.



É obrigatório o uso de Ultrassom



Uso Mandatório de Ultrassom

- Ultrassom é obrigatório para guiar acessos venosos centrais.
- Garante segurança e eficácia do procedimento.



Notificação e Justificativa de não uso

• Ultrassom indisponível

Na impossibilidade de utilização do ultrassom (USG), a **gestão da Performa Saúde deve ser notificada de forma imediata**, garantindo rastreabilidade e transparência do evento.

A notificação deverá ser realizada **obrigatoriamente** nos seguintes links:

- Sistema CEJAM – Eventos Adversos:
<https://cejam.medicsys.com.br/EventosAdversosweb>
- Formulário Performa Saúde:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL5ZjSpu9wDRi2jw8g01a33vybKdFKSg7d8cqjKBVfVSOUvw/viewform?usp=preview>

No registro, **descrever de forma clara e objetiva o motivo da não utilização do USG**, especificando se a indisponibilidade foi por ausência do equipamento no setor, compartilhamento com outro serviço, falha técnica ou outro fator operacional.

- Adicionalmente, **solicitar formalmente ao auditor de bundles** que registre, no campo de observações, a seguinte informação:

“Procedimento realizado sem ultrassonografia devido à indisponibilidade do USG no setor no momento da assistência.”





Materiais para o Procedimento

Barreira de Proteção Máxima

Uso obrigatório para segurança, inclui:

- Luvas estéreis
- Capote
- Máscara
- Gorro
- Grande campo estéril

Instrumentos Essenciais

- Bisturi
- Dilatador rígido do CVC
- Jelco 14
- Agulhas metálicas
- Seringa de 10mL

Componentes do Cateter

- Fio guia do cateter central
- Cateter CVC (mono, duplo ou triplo lúmen)

Fixação e Conexão

- Presilhas para pele
- Conectores
- Fio de sutura

Considerações Importantes

- Avaliar agitação do paciente
- Transdutor linear: visualização precisa de estruturas superficiais (alta frequência)



BARREIRA DE PROTEÇÃO MÁXIMA



Luvas Estéreis

Essenciais para manter a assepsia.



Capote

Proteção completa do profissional.



Máscara

Previne contaminação por gotículas.



Gorro

Cobre o cabelo e evita contaminação.



Grande Campo Estéril

Cria área de trabalho livre de micro-organismos.

ANTISSEPSIA DA PELE

01

Degermação Inicial

- Com Clorexidina 2% ou 4% degermante.
- Movimentos circulares do centro para a periferia (3x).
- Até pele visivelmente limpa.

02

Antissepsia Complementar

- Aplicar Clorexidina alcoólica a 0,5%.
- Manter movimentos circulares centro-periferia.

03

Tempo de Secagem

- Aguardar 30 segundos.
- Garantir a eficácia do antisséptico.

LIMPEZA DO APARELHO

O enfermeiro realiza a limpeza do probe do ultrassom para uso imediato.

PREPARO DAS MÃOS

01

Indicação

Essencial antes de procedimentos invasivos estéreis (ex: inserção de CVC).

02

Escovação Cirúrgica

Usar escova esteril com antisséptico (PVPI ou Clorexidina). Esfregar mãos e antebraços.

03

Duração

Escovar por 3-5 minutos, conforme protocolo, para assepsia eficaz.

04

Áreas Críticas

Priorizar unhas, espaços interdigitais, dedos e punhos para remover sujidades e microrganismos.

05

Secagem Asséptica

Secar com compressas estéreis. Movimentos únicos: dedos aos cotovelos, sem retorno.

HIGIENIZE AS MÃOS: SALVE VIDAS

Anti-sepsia ou Preparo Pré-Operatório das Mãos



1. Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos.



2. Recolher, com as mãos em corcha, o anti-séptico e espalhar nas mãos, antebraço e cotovelo. No caso de escova impregnada com anti-séptico, pressionar a parte da esponja contra a pele e espalhar por todas as partes.



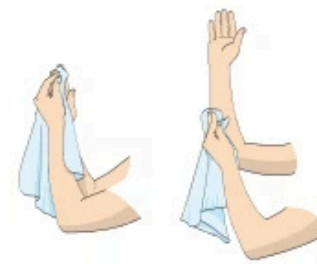
3. Limpar sob as unhas com as cerdas da escova ou com limpador de unhas.



4. Friccionar as mãos, observando dedos, espaços interdigitais e antebraços por no mínimo 3 a 5 minutos, mantendo as mãos acima dos cotovelos.



5. Enxaguar as mãos em água corrente, no sentido das mãos para cotovelos, retirando todo resíduo do produto. Fechar a torneira com o cotovelo, joelho ou pé, se a torneira não possuir foto sensor.



6. Enxugar as mãos em toalhas ou compressas estéreis, com movimentos compressivos, iniciando pelas mãos e seguindo pelo antebraço e cotovelo, atendo para utilizar as diferentes dobras da toalha/compressa para regiões distintas.

PREPARAÇÃO DO SÍTIO DE INSERÇÃO

01

Seleção e Demarcação

Identificar o local ideal para o cateter.

Demarcar a área, considerando anatomia e pontos de referência.

02

Colocação dos Campos Estéreis

Aplicar campos estéreis sobre o paciente.

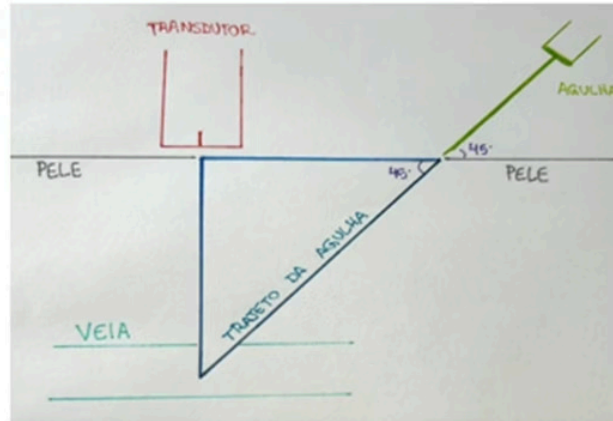
Criar barreira asséptica para prevenir contaminação.



POSICIONAR A AGULHA



1. Identificação da veia jugular
2. Preparar a agulha metálica conectada a uma seringa de 10mL.
3. A agulha deve ser inserida formando um ângulo de 45° com a pele, de modo que a distância do transdutor e a profundidade a ser atingida sejam as mesmas.



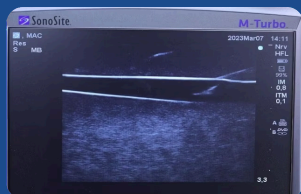
Dica: A ideia é simular um triângulo isósceles, em que a hipotenusa é o trajeto da agulha e os catetos são formados pela distância do ponto de inserção ao transdutor e do transdutor ao ponto a ser atingido.

- Inserir a agulha com o bisel para cima, mantendo um ângulo de 10-30 graus em relação à pele.
- Avançar lentamente até sentir uma leve perda de resistência e observar o refluxo de sangue na câmara da agulha.
- Confirmar a entrada na veia antes de prosseguir com a inserção do cateter.

Inserir a Agulha - Verificar o Trajeto

1. Verificar Trajeto

Verifique o trajeto da agulha com ultrassom.



2. Aspirar Sangue

Com a agulha no vaso, aspire com a seringa para confirmar posicionamento (regurgitação de sangue).

3. Confirmar Vaso

Visualize o trajeto da agulha com o transdutor e aspire para confirmar o vaso (refluxo de sangue).

4. Inserir Fio-Guia e Dilatador

Insira o fio-guia com a ponta "J" para baixo. Em seguida, o dilatador para expandir o orifício e facilitar a inserção do cateter.

5. Inserir Cateter

Retire o fio-guia e o alargador. Insira o cateter.

6. Teste de Refluxo

Desça a ponta externa do cateter (abaixo do ponto de punção) para verificar o refluxo de sangue por gravidade, confirmando a posição intravenosa.

7. Fixar Cateter

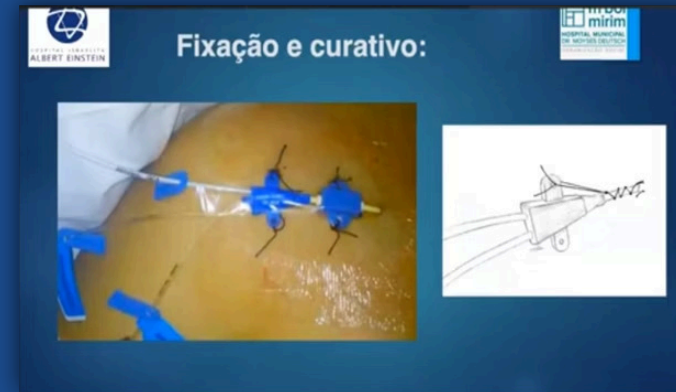
Após confirmar a posição adequada, fixe o cateter à pele, preferencialmente com ponto simples.

8. Obrigatório: Métodos de Confirmação

- Identificação do fio-guia na veia com ultrassom.
- Teste de refluxo.
- Raio X de tórax controle após TODAS as punções.
- Verificar o caráter do refluxo e a cor do sangue na punção.

Técnica Asséptica na Inserção do Cateter Venoso Central

1. Fixe o cateter com pontos simples a borboleta e a bailarina.
2. Limpe a região do cateter com clorexidine alcoólico.
3. Faça curativo oclusivo com gazes e película transparente.
4. Descarte o material na caixa de perfurocortantes.
5. Solicitar radiografia de tórax para confirmar posicionamento do CVC e descartar acidentes de punção.



A correta aplicação da técnica asséptica é fundamental em cada etapa da inserção do cateter venoso central (CVC) para prevenir infecções.

Preparação e Campo Estéril

Preparação do campo estéril e manuseio de materiais com vestimenta e luvas estéreis para evitar contaminação.

Manuseio do Cateter

Manusear o cateter com precisão, mantendo-o estéril da embalagem à inserção. Essencial para segurança do paciente e sucesso do procedimento.

IMPORTANTE COLOCAR EM EVOLUÇÃO



Relatório do Procedimento

A descrição completa do procedimento deve ser registrada detalhadamente.



Obtenção da Radiografia (RX)

Registrar na evolução a solicitação da radiografia, incluindo o horário da realização.



Liberação para Uso do Cateter

Deve constar na evolução a liberação para uso do cateter após avaliação da radiografia.



Uso de Sítios Não Recomendados

Registrar justificativa detalhada para uso de sítios alternativos, explicando o motivo e garantindo transparência.

IMPORTÂNCIA DE SEGUIR OS PROTOCOLOS

Benefícios dos Protocolos Institucionais:

- Garantem a segurança do paciente e a qualidade do atendimento.
- O cumprimento rigoroso de cada etapa pode ser decisivo.
- Reduzem erros e padronizam condutas baseadas em evidências.
- Asseguram os melhores desfechos clínicos.

LISTA DE PRESENÇA OBRIGATÓRIA, ASSINE NO LINK ABAIXO

<https://forms.gle/JYkag352X5vj69gm7>